

CURSO EM PDF — TDAH

Curso Robusto de TDAH — Base Barkley

Diagnóstico, avaliação, tratamento, prática clínica e aplicação pericial.

Preparado para: Dr. Luís Henrique B. Gomes — Psiquiatra.

Base de referência: Russell A. Barkley e colaboradores, Manual para Diagnóstico e Tratamento.

Nota: material autoral e aplicado; não reproduz o livro.

Curso Robusto de TDAH — Diagnóstico, Avaliação e Tratamento

Base principal: Russell A. Barkley e colaboradores, Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade: Manual para Diagnóstico e Tratamento, 3ª ed., Artmed, 2008.

Este curso é um material autoral de estudo e aplicação clínica, estruturado a partir dos eixos conceituais do manual. Não reproduz o livro; organiza uma trilha prática para estudo médico, atendimento clínico e uso pericial.

Público-alvo

- Médico psiquiatra.
- Médico do trabalho.
- Perito/assistente técnico em saúde mental.
- Profissional que precise avaliar TDAH em crianças, adolescentes ou adultos com rigor clínico.

Objetivo geral

Construir domínio clínico robusto sobre TDAH: história, conceituação, critérios diagnósticos, etiologia, comorbidades, avaliação, diagnóstico diferencial, manejo psicossocial, intervenções escolares/familiares, farmacoterapia e aplicação médico-pericial.

Competências ao final do curso

Ao final, o aluno deverá ser capaz de:

1. Explicar o TDAH como transtorno do neurodesenvolvimento ligado a desinibição, autorregulação e funções executivas.
2. Reconhecer sintomas nucleares e apresentações clínicas em crianças, adolescentes e adultos.
3. Diferenciar TDAH de variações normais do comportamento, transtornos de humor, ansiedade, trauma, uso de substâncias, transtornos de aprendizagem e condições médicas.

4. Conduzir entrevista diagnóstica estruturada com múltiplas fontes.
5. Usar escalas e dados escolares/ocupacionais sem transformar escala em diagnóstico isolado.
6. Integrar história longitudinal, prejuízo funcional, início no desenvolvimento e pervasividade situacional.
7. Planejar tratamento multimodal: psicoeducação, manejo parental, escola, intervenções comportamentais, organização ambiental, psicoterapia e farmacoterapia.
8. Avaliar TDAH adulto com foco em funcionamento, comorbidades, compensações, risco ocupacional e diagnóstico retrospectivo.
9. Elaborar documentos clínicos ou periciais sem superdiagnóstico, sem reducionismo e sem conclusões não sustentadas.

Carga horária sugerida

Curso completo: 60 horas.

- 30 horas de aulas teóricas.
- 15 horas de estudo dirigido do manual.
- 10 horas de casos clínicos.
- 5 horas de produção prática: checklists, entrevistas, laudos/relatórios e plano terapêutico.

Versão intensiva: 24 horas.

Versão profunda: 90 horas com seminários e revisão bibliográfica atualizada.

Arquitetura geral

O curso é dividido em 8 módulos:

1. Fundamentos e história do TDAH.
2. Psicopatologia, critérios diagnósticos e epidemiologia.
3. Cognição, desenvolvimento, comorbidades e etiologia.
4. TDAH em adultos e teoria executiva do Barkley.
5. Avaliação clínica e psicométrica.
6. Tratamento psicossocial, familiar e escolar.
7. Farmacoterapia e tratamento combinado.

8. Aplicações clínicas avançadas, ocupacionais e periciais.

Módulo 1 — Fundamentos e História do TDAH

Aula 1. O que é TDAH e por que ele é controverso

Objetivos

- Definir TDAH como transtorno do neurodesenvolvimento.
- Diferenciar controvérsia social de validade clínica.
- Entender por que TDAH não é apenas “falta de atenção”.

Conteúdos

- TDAH como síndrome clínica heterogênea.
- Inatenção, hiperatividade e impulsividade.
- Prejuízo funcional como eixo diagnóstico.
- Risco de banalização versus risco de subdiagnóstico.
- O lugar do manual de Barkley na literatura.

Perguntas-chave

- Quando comportamento ativo vira sintoma?
- Por que diagnóstico exige prejuízo, desenvolvimento e contexto?
- O que torna o TDAH clinicamente válido?

Produto prático

Mapa mental: “TDAH: sintomas, prejuízo, desenvolvimento e contexto”.

Aula 2. História conceitual do TDAH

Objetivos

- Compreender a evolução histórica do conceito.
- Relacionar modelos antigos com o modelo atual de autorregulação.

Conteúdos

- Descrições históricas de desatenção, hiperatividade e impulsividade.
- Noções antigas de controle moral, lesão cerebral mínima e hiperatividade.
- Transição para critérios diagnósticos operacionais.
- Por que a história ajuda a evitar erros atuais.

Produto prático

Linha do tempo resumida da evolução conceitual do TDAH.

Módulo 2 — Psicopatologia, Diagnóstico e Epidemiologia

Aula 3. Sintomas nucleares: inatenção

Objetivos

- Diferenciar distraibilidade comum de inatenção patológica.
- Avaliar inatenção por tarefas, idade e exigência ambiental.

Conteúdos

- Persistência em tarefas.
- Sustentação de esforço mental.
- Organização e esquecimento.
- Atenção como função dependente de motivação, reforço, contexto e autorregulação.

Produto prático

Checklist clínico de inatenção por faixa etária.

Aula 4. Sintomas nucleares: hiperatividade e impulsividade

Objetivos

- Avaliar hiperatividade motora, inquietação interna e impulsividade.
- Diferenciar sintomas infantis e adultos.

Conteúdos

- Hiperatividade em criança versus inquietação subjetiva no adulto.
- Impulsividade verbal, decisória, emocional e comportamental.
- Busca de recompensa imediata.
- Problemas de espera, turno, interrupção e risco.

Produto prático

Roteiro de perguntas sobre impulsividade funcional.

Aula 5. Critérios diagnósticos, idade de início e pervasividade

Objetivos

- Usar critérios diagnósticos sem mecanicismo.
- Entender o papel da idade de início e da presença em múltiplos contextos.

Conteúdos

- Critérios DSM e CID: lógica geral.
- Sintomas suficientes, persistentes, desenvolvimentalmente inadequados.
- Prejuízo em dois ou mais contextos.
- Erros comuns: escala positiva sem história; sintoma sem prejuízo; queixa adulta sem rastreio retrospectivo.

Produto prático

Fluxograma diagnóstico clínico.

Aula 6. Prevalência, gênero e heterogeneidade clínica

Objetivos

- Entender prevalência e diferenças de gênero.
- Reconhecer subapresentações e vieses de encaminhamento.

Conteúdos

- Variações por método, informante e critério.
- Meninos, meninas e formas menos disruptivas.
- Falso negativo em alto funcionamento.
- Falso positivo em contextos de trauma, negligência, ansiedade ou depressão.

Produto prático

Quadro: “risco de subdiagnóstico versus superdiagnóstico”.

Módulo 3 — Cognição, Desenvolvimento, Comorbidades e Etiologia

Aula 7. Problemas cognitivos e desenvolvimento

Objetivos

- Entender impacto em aprendizagem, função executiva e desenvolvimento.

Conteúdos

- Memória de trabalho.
- Planejamento.
- Organização temporal.
- Desempenho acadêmico.
- Regulação emocional e motivacional.
- Desenvolvimento longitudinal do prejuízo.

Produto prático

Tabela de prejuízos por domínio: escola, família, pares, autocuidado.

Aula 8. Saúde, riscos e consequências funcionais

Objetivos

- Reconhecer riscos clínicos e funcionais associados.

Conteúdos

- Acidentes, impulsividade, adesão baixa, sono, uso de substâncias.
- Autoestima, conflitos familiares e escolares.
- Consequências ocupacionais no adulto.

Produto prático

Checklist de riscos clínicos em TDAH.

Aula 9. Comorbidades principais

Objetivos

- Avaliar comorbidades sem perder a hierarquia diagnóstica.

Conteúdos

- Transtorno opositor/desafiador e conduta.
- Transtornos de aprendizagem.
- Ansiedade.
- Depressão.
- Transtorno bipolar: cuidado com diagnóstico diferencial.
- Transtornos do sono.
- Uso de substâncias.
- TEA e tiques.

Produto prático

Matriz de diagnóstico diferencial e comorbidades.

Aula 10. Etiologia: genética, neurobiologia e ambiente

Objetivos

- Entender TDAH como condição multifatorial com forte base neurobiológica.

Conteúdos

- Hereditariedade.
- Neurodesenvolvimento.
- Circuitos frontoestriatais e funções executivas.
- Fatores ambientais de risco.
- O que não causa TDAH: reducionismos familiares/morais.

Produto prático

Explicação psicoeducativa de 1 página para paciente/família.

Módulo 4 — TDAH em Adultos e Teoria Executiva

Aula 11. Curso evolutivo: da infância à vida adulta

Objetivos

- Compreender persistência, remissão parcial e mudança de apresentação.

Conteúdos

- O que melhora com idade.
- O que persiste.
- Compensações, colapsos funcionais e demandas crescentes.
- Relações, trabalho, finanças e direção veicular.

Produto prático

Roteiro de anamnese longitudinal do TDAH adulto.

Aula 12. Avaliação do TDAH adulto

Objetivos

- Fazer diagnóstico adulto com segurança.

Conteúdos

- Queixa atual.
- História escolar e familiar.
- Evidência retrospectiva.
- Informantes colaterais.
- Comorbidades adultas.
- Diferenciar TDAH de ansiedade, depressão, burnout, trauma e privação de sono.

Produto prático

Entrevista estruturada para TDAH adulto.

Aula 13. Teoria do Barkley: inibição e autorregulação

Objetivos

- Dominar a formulação teórica de Barkley.

Conteúdos

- TDAH como transtorno de inibição comportamental.
- Autorregulação e funções executivas.
- Memória de trabalho não verbal/verbal.
- Internalização da fala.
- Autorregulação emocional/motivacional.
- Reconstituição e planejamento.

Produto prático

Modelo clínico: do sintoma ao prejuízo funcional.

Aula 14. Implicações práticas da teoria executiva

Objetivos

- Traduzir teoria em intervenção.

Conteúdos

- Por que “saber o que fazer” não basta.
- Externalização de regras, tempo e consequências.
- Intervenções no ponto de desempenho.
- Reforço imediato e ambiente estruturado.

Produto prático

Plano ambiental de manejo para adulto com TDAH.

Módulo 5 — Avaliação Clínica e Psicométrica

Aula 15. Entrevista diagnóstica

Objetivos

- Conduzir avaliação completa em criança/adolescente.

Conteúdos

- Queixa principal.
- Desenvolvimento.
- História escolar.
- Família.
- Relato de pais e professores.
- Prejuízo funcional.
- Comorbidades.
- Exame médico e condições mimetizadoras.

Produto prático

Modelo de entrevista inicial.

Aula 16. Escalas de avaliação comportamental

Objetivos

- Usar escalas corretamente.

Conteúdos

- Escalas como apoio, não diagnóstico isolado.
- Múltiplos informantes.
- Ponto de corte versus julgamento clínico.
- Sensibilidade, especificidade e validade ecológica.

Produto prático

Protocolo de uso de escalas em consultório.

Aula 17. Testes, medidas observacionais e limitações

Objetivos

- Entender quando testes ajudam e quando confundem.

Conteúdos

- Testes neuropsicológicos.
- Testes contínuos de desempenho.
- Observação clínica.
- Função executiva em teste versus vida real.
- Limitações para conclusão pericial.

Produto prático

Texto padrão: “limitações dos testes na avaliação de TDAH”.

Aula 18. Integração diagnóstica por casos

Objetivos

- Aprender a integrar dados divergentes.

Conteúdos

- Relato dos pais positivo e escola negativa.
- Escola positiva e pais negativos.
- Alto QI e prejuízo oculto.
- Comorbidade dominante.
- Suspeita de simulação/dissimulação.
- Adulto com documentação infantil escassa.

Produto prático

Template de formulação diagnóstica integrativa.

Módulo 6 — Tratamento Psicossocial, Familiar e Escolar

Aula 19. Psicoeducação e aconselhamento familiar

Objetivos

- Comunicar diagnóstico e orientar família sem culpabilização.

Conteúdos

- TDAH como condição crônica manejável.
- Expectativas realistas.
- Manejo de reforço, rotina e consequências.
- Aliança terapêutica com pais.

Produto prático

Roteiro de devolutiva diagnóstica para pais.

Aula 20. Treinamento parental

Objetivos

- Estruturar intervenção comportamental parental.

Conteúdos

- Regras claras.
- Reforço positivo.
- Economia de fichas.
- Consequências breves e consistentes.
- Monitoramento.
- Prevenção de escaladas coercitivas.

Produto prático

Plano de 4 semanas para manejo parental.

Aula 21. Adolescente com TDAH

Objetivos

- Ajustar tratamento para autonomia, conflito familiar e risco.

Conteúdos

- Adesão baixa.
- Negociação familiar.
- Escola, estudo, direção, sexualidade, substâncias e internet.
- Contratos comportamentais.

Produto prático

Contrato familiar para adolescente.

Aula 22. Intervenções escolares

Objetivos

- Planejar manejo escolar baseado em ambiente.

Conteúdos

- Sala de aula estruturada.
- Redução de distração.
- Tarefas fracionadas.
- Feedback imediato.
- Comunicação escola-família.
- Adaptações razoáveis sem privilégio indevido.

Produto prático

Carta técnica para escola.

Aula 23. Mediação de conflitos e habilidades sociais

Objetivos

- Entender impacto social e estratégias de mediação.

Conteúdos

- Rejeição por pares.
- Impulsividade interpessoal.
- Treino de solução de problemas.
- Mediação escolar.
- Prevenção de agressividade.

Produto prático

Plano de intervenção social/escolar.

Módulo 7 — Farmacoterapia e Tratamento Combinado

Aula 24. Estimulantes

Objetivos

- Entender papel, eficácia, limites e monitoramento.

Conteúdos

- Metilfenidato e anfetaminas: lógica geral.
- Formulações de curta e longa ação.
- Titulação e monitoramento.
- Efeitos adversos.
- Contraindicações e cautelas.
- Adesão e expectativas.

Produto prático

Checklist de início e seguimento de estimulante.

Aula 25. Atomoxetina, antidepressivos e outros medicamentos

Objetivos

- Conhecer alternativas e indicações específicas.

Conteúdos

- Inibidores de recaptação de norepinefrina.
- Antidepressivos usados em contextos selecionados.
- Alfa-agonistas e outras opções.
- Comorbidades e escolha terapêutica.

Produto prático

Algoritmo clínico de escolha farmacológica.

Aula 26. Tratamento combinado e estudo MTA

Objetivos

- Entender evidência de tratamento combinado.

Conteúdos

- Farmacoterapia isolada.
- Tratamento comportamental.
- Intervenções combinadas.
- Quando combinar.
- O que muda no mundo real.

Produto prático

Plano terapêutico multimodal.

Aula 27. Acompanhamento longitudinal

Objetivos

- Planejar seguimento de longo prazo.

Conteúdos

- Monitorar sintomas e prejuízo.
- Crescimento, sono, apetite, humor, pressão arterial.
- Escola/trabalho.
- Risco de abuso/desvio de medicação.
- Reavaliação diagnóstica.

Produto prático

Ficha de seguimento trimestral.

Módulo 8 — Aplicações Avançadas, Ocupacionais e Periciais

Aula 28. TDAH no trabalho e na vida adulta funcional

Objetivos

- Avaliar impacto ocupacional sem confundir diagnóstico com incapacidade.

Conteúdos

- Organização, prazos, hierarquia, erros, procrastinação.
- Direção, segurança e atividades de risco.
- Ajustes ambientais.
- TDAH e burnout.
- TDAH e medicina do trabalho.

Produto prático

Checklist ocupacional para adulto com TDAH.

Aula 29. TDAH em perícias psiquiátricas

Objetivos

- Aplicar rigor pericial ao TDAH.

Conteúdos

- Diagnóstico não equivale a incapacidade.
- Capacidade civil e TDAH.
- Capacidade laboral e TDAH.
- Risco de superatribuição causal.
- Documentação longitudinal.
- Simulação, amplificação e inconsistências.

Produto prático

Template de análise pericial de TDAH.

Aula 30. Casos complexos e formulação final

Objetivos

- Integrar todo o curso em casos clínicos.

Conteúdos

- Criança com TDAH + TOD.
- Adolescente com TDAH + uso de substâncias.
- Adulto com TDAH + depressão/ansiedade.
- Adulto com queixa de TDAH mas quadro primário de sono/burnout.
- Pedido pericial de incapacidade por TDAH.

Produto prático

Relatório final de formulação clínica e plano de tratamento.

Avaliação do curso

Avaliação formativa

- Mapas mentais por módulo.
- Discussão de casos curtos.
- Respostas a perguntas clínicas fundamentais.
- Construção progressiva de checklists.

Avaliação final

O aluno deve entregar:

1. Uma formulação diagnóstica completa de caso clínico.
2. Um plano terapêutico multimodal.
3. Uma análise de diagnóstico diferencial.
4. Um modelo de relatório/parecer técnico sobre TDAH.

Critérios de aprovação

- Formulação coerente com dados fornecidos.
 - Separação entre sintomas, diagnóstico e prejuízo funcional.
 - Consideração de comorbidades e diagnósticos diferenciais.
 - Plano terapêutico individualizado.
 - Linguagem técnica, clara e não estigmatizante.
-

Leituras dirigidas pelo manual

Parte I — Natureza do TDAH

- Cap. 1: História.
- Cap. 2: Sintomas, critérios diagnósticos, prevalência e gênero.
- Cap. 3: Problemas cognitivos, desenvolvimento e saúde.
- Cap. 4: Comorbidades, adaptação social/familiar e subtipos.
- Cap. 5: Etiologias.
- Cap. 6: TDAH em adultos.
- Cap. 7: Teoria do TDAH.

Parte II — Avaliação

- Cap. 8: Entrevista diagnóstica, escalas e exame médico.
- Cap. 9: Testes e medidas observacionais.
- Cap. 10: Integração dos resultados por casos clínicos.
- Cap. 11: Avaliação de adultos.

Parte III — Tratamento

- Cap. 12: Aconselhamento e treinamento para pais.
 - Cap. 13: COPE.
 - Cap. 14: Treinamento para famílias de adolescentes.
 - Cap. 15: Tratamento em ambientes escolares.
 - Cap. 16: Programas de resolução de conflitos.
 - Cap. 17: Estimulantes.
 - Cap. 18: Antidepressivos e inibidores de recaptação de norepinefrina.
 - Cap. 19: Outros medicamentos.
 - Cap. 20: Terapias infantis combinadas.
 - Cap. 21: Aconselhamento psicológico de adultos.
 - Cap. 22: Farmacoterapia em adultos.
-

Atualização necessária

O manual é de 2008. Para uso clínico atual, complementar com:

- DSM-5-TR.
 - CID-11.
 - diretrizes nacionais/internacionais recentes;
 - consensos sobre TDAH adulto;
 - literatura recente sobre tratamento farmacológico, comorbidades, riscos cardiovasculares e telemedicina;
 - legislação e normas atuais quando houver finalidade pericial, escolar ou ocupacional.
-

Cronograma de 12 semanas — Curso Robusto de TDAH

Semana 1 — Fundamentos

- Aula 1: O que é TDAH e por que ele é controverso.
- Aula 2: História conceitual do TDAH.
- Leitura: Cap. 1.
- Entrega: mapa mental do conceito de TDAH.

Semana 2 — Sintomas e diagnóstico

- Aula 3: Inatenção.
- Aula 4: Hiperatividade e impulsividade.
- Leitura: Cap. 2.
- Entrega: checklist de sintomas por faixa etária.

Semana 3 — Critérios, prevalência e gênero

- Aula 5: Critérios diagnósticos, idade de início e pervasividade.
- Aula 6: Prevalência, gênero e heterogeneidade.
- Leitura: Cap. 2.
- Entrega: fluxograma diagnóstico.

Semana 4 — Cognição e comorbidades

- Aula 7: Problemas cognitivos e desenvolvimento.
- Aula 8: Saúde, riscos e consequências funcionais.
- Aula 9: Comorbidades principais.
- Leitura: Caps. 3 e 4.
- Entrega: matriz de diagnóstico diferencial.

Semana 5 — Etiologia e teoria

- Aula 10: Etiologia.
- Aula 13: Teoria do Barkley.
- Aula 14: Implicações práticas da teoria executiva.
- Leitura: Caps. 5 e 7.
- Entrega: explicação psicoeducativa para paciente/família.

Semana 6 — TDAH adulto

- Aula 11: Curso evolutivo.
- Aula 12: Avaliação de adultos.
- Leitura: Caps. 6 e 11.
- Entrega: roteiro de anamnese longitudinal.

Semana 7 — Avaliação clínica

- Aula 15: Entrevista diagnóstica.
- Aula 16: Escalas de avaliação.
- Leitura: Cap. 8.
- Entrega: protocolo de avaliação clínica.

Semana 8 — Testes e integração

- Aula 17: Testes e medidas observacionais.
- Aula 18: Integração diagnóstica por casos.
- Leitura: Caps. 9 e 10.
- Entrega: formulação diagnóstica integrativa.

Semana 9 — Família, pais e adolescentes

- Aula 19: Psicoeducação familiar.
- Aula 20: Treinamento parental.
- Aula 21: Adolescente com TDAH.
- Leitura: Caps. 12 a 14.
- Entrega: plano de manejo familiar.

Semana 10 — Escola e habilidades sociais

- Aula 22: Intervenções escolares.
- Aula 23: Mediação de conflitos e habilidades sociais.
- Leitura: Caps. 15 e 16.
- Entrega: carta técnica para escola.

Semana 11 — Farmacoterapia

- Aula 24: Estimulantes.
- Aula 25: Atomoxetina, antidepressivos e outros medicamentos.
- Aula 26: Tratamento combinado.
- Leitura: Caps. 17 a 20 e 22.
- Entrega: algoritmo terapêutico.

Semana 12 — Adultos, trabalho e perícia

- Aula 27: Acompanhamento longitudinal.
 - Aula 28: TDAH no trabalho.
 - Aula 29: TDAH em perícias psiquiátricas.
 - Aula 30: Casos complexos.
 - Leitura: Cap. 21 e revisão geral.
 - Entrega final: formulação clínica + plano terapêutico + análise pericial curta.
-

Materiais práticos — Curso de TDAH

1. Checklist de triagem inicial

- Queixa principal: []
- Idade de início provável: []
- Sintomas atuais de inatenção: []
- Sintomas atuais de hiperatividade/impulsividade: []
- Prejuízo funcional: []
- Contextos afetados: família / escola / trabalho / social / trânsito / finanças
- Informantes disponíveis: []
- Documentos escolares/ocupacionais: []
- Comorbidades suspeitas: []
- Diagnósticos diferenciais prioritários: []
- Uso de substâncias: []
- Sono: []
- Condições médicas/medicações: []

2. Entrevista clínica — criança/adolescente

Pais/cuidadores

1. Quando começaram as dificuldades?
2. Em quais contextos aparecem?
3. Há prejuízo escolar, familiar ou social?
4. Como é a rotina de sono?
5. Como responde a regras, espera, frustração e consequências?
6. Há agressividade, oposição, ansiedade, tristeza, tiques, autismo, dificuldades de aprendizagem?
7. Há histórico familiar de TDAH ou transtornos psiquiátricos?
8. O que já foi tentado?

Escola

1. Atenção em tarefas longas.
2. Organização de material.
3. Entrega de tarefas.
4. Impulsividade em sala.
5. Relação com colegas.
6. Desempenho por matéria.
7. Diferença entre capacidade aparente e produção.
8. Resposta a estrutura e reforço.

3. Entrevista clínica — adulto

1. Qual problema atual motivou avaliação?
2. Há história infantil compatível?
3. Como foi desempenho escolar, repetências, advertências, desorganização ou procrastinação?
4. Quais prejuízos atuais no trabalho?
5. Há prejuízo em finanças, trânsito, relacionamentos, saúde ou rotina doméstica?
6. O quadro é crônico ou começou após evento específico?
7. Há depressão, ansiedade, bipolaridade, trauma, sono ruim ou uso de substâncias explicando melhor?
8. Quais estratégias compensatórias funcionam?
9. Há informante colateral?
10. O paciente busca tratamento, laudo, medicação, benefício ou acomodação?

4. Matriz de diagnóstico diferencial

TDAH versus ansiedade

- TDAH: desatenção crônica, desde desenvolvimento, em tarefas pouco reforçadoras.
- Ansiedade: desatenção dominada por preocupação, ruminação, medo antecipatório.

TDAH versus depressão

- TDAH: início precoce, curso estável/crônico.

- Depressão: queda de energia, anedonia, lentificação e concentração reduzida em episódio afetivo.

TDAH versus bipolaridade

- TDAH: impulsividade persistente, não episódica.
- Bipolaridade: episódios delimitados com alteração de humor, energia, sono e grandiosidade.

TDAH versus trauma/TEPT

- TDAH: autorregulação prejudicada desde cedo.
- TEPT: sintomas após trauma, hipervigilância, revivescência, esquiva, gatilhos traumáticos.

TDAH versus privação de sono

- TDAH: histórico longitudinal.
- Sono: piora associada a sono insuficiente, apneia, insônia, ritmo irregular.

TDAH versus uso de substâncias

- TDAH: sintomas antecedem uso.
- Substâncias: sintomas flutuam com intoxicação, abstinência ou padrão de consumo.

5. Formulação diagnóstica integrativa

Dados que sustentam TDAH

- [SINTOMAS]
- [IDADE DE INÍCIO]
- [PERVASIVIDADE]
- [PREJUÍZO]
- [HISTÓRIA LONGITUDINAL]
- [INFORMANTES]
- [ESCALAS]

Dados contra TDAH ou que exigem cautela

- [DADOS]

Comorbidades

- [COMORBIDADES]

Diagnóstico diferencial

- [HIPÓTESES]

Conclusão

Com base nos dados fornecidos, há/não há elementos suficientes para diagnóstico de TDAH, pois [JUSTIFICATIVA].

6. Plano terapêutico multimodal

Psicoeducação

- Explicar TDAH como transtorno de autorregulação.
- Separar culpa de responsabilidade.
- Definir metas observáveis.

Ambiente

- Externalizar tempo.
- Quebrar tarefas.
- Reduzir distrações.
- Usar lembretes visuais.
- Feedback imediato.

Família/escola/trabalho

- Ajustes específicos: []
- Comunicação com escola/empresa: []
- Monitoramento: []

Psicoterapia/intervenção comportamental

- Habilidades organizacionais.
- Planejamento.
- Resolução de problemas.
- Manejo emocional.

Farmacoterapia

- Indicação: []
- Opção inicial: []
- Monitoramento: sono, apetite, PA/FC, humor, adesão, efeitos adversos.

7. Checklist médico-pericial de TDAH

- Diagnóstico foi estabelecido com base longitudinal?
- Há documentação desde infância/adolescência?
- Há prejuízo funcional concreto?
- O prejuízo é atual?
- Há comorbidade que explica melhor a incapacidade?
- Há relação entre diagnóstico e atividade laboral específica?
- Há possibilidade de adaptação/readaptação?
- O diagnóstico está sendo confundido com incapacidade?
- Há inconsistências entre relato, documentos e observação?
- A conclusão está limitada aos dados disponíveis?

8. Modelo curto de relatório clínico

Paciente [PACIENTE], avaliado em [DATA], apresenta história compatível/incompatível com TDAH, considerando [SINTOMAS], [INÍCIO], [PERVASIVIDADE] e [PREJUÍZO]. Foram considerados diagnósticos diferenciais como [DIFERENCIAIS]. A avaliação sugere [CONCLUSÃO], com impacto funcional em [DOMÍNIOS]. Recomenda-se [PLANO].

9. Modelo curto de conclusão pericial

Há elementos clínicos/documentais suficientes/insuficientes para afirmar diagnóstico de TDAH em [PERICIANDO]. O diagnóstico, isoladamente, não determina incapacidade. A análise funcional demonstra [DESCREVER PREJUÍZO], com repercussão sobre [ATOS/CARGO/FUNÇÕES]. Considerando os dados disponíveis, conclui-se por [CONCLUSÃO], respeitadas as limitações de [LIMITAÇÕES].

TDAH — Pontos úteis para a prática diária do psiquiatra clínico

Material autoral de apoio ao curso de TDAH, baseado nos eixos clínicos do manual de Barkley e adaptado para rotina de consultório psiquiátrico.

1. Regra de ouro no consultório

TDAH não é diagnosticado por “distração”.

O diagnóstico exige quatro pilares:

1. Sintomas nucleares persistentes: inatenção e/ou hiperatividade-impulsividade.
2. Início no desenvolvimento: sinais desde infância/adolescência, ainda que só tenham causado colapso funcional na vida adulta.
3. Prejuízo funcional concreto: escola, trabalho, vida doméstica, finanças, relacionamentos, trânsito, saúde ou rotina.
4. Pervasividade: sintomas em mais de um contexto, não apenas em uma situação específica.

Se faltar prejuízo funcional, é traço. Se faltar história longitudinal, é hipótese. Se os sintomas começaram depois de depressão, trauma, privação de sono ou burnout, primeiro investigar esses quadros.

2. A pergunta clínica central

Em vez de perguntar apenas “você se distrai?”, perguntar:

O que você sabe que precisa fazer, tem capacidade de fazer, quer fazer, mas repetidamente não consegue executar no momento certo?

Essa pergunta captura melhor a noção barkleyana de TDAH como transtorno de desempenho/autorregulação, e não apenas de conhecimento ou inteligência.

3. Sinais clínicos fortes em adultos

São pistas úteis:

- vida marcada por potencial alto e entrega irregular;
- histórico de procrastinação crônica;
- atraso recorrente apesar de intenção sincera;
- acúmulo de tarefas simples;
- dificuldade de iniciar o que não tem urgência ou novidade;
- melhora em crise/prazo e piora em rotina;
- múltiplos projetos iniciados e poucos concluídos;
- desorganização financeira, doméstica ou documental;
- esquecimentos com impacto relacional ou profissional;
- impulsividade verbal, compras, direção, decisões ou conflitos;
- instabilidade ocupacional desproporcional à capacidade técnica;
- sensação de “viver apagando incêndio”.

4. Pistas que pedem cautela diagnóstica

Redobrar cuidado quando:

- queixa começou apenas na vida adulta sem indícios prévios;
- há privação crônica de sono;
- há ansiedade intensa com ruminação dominante;
- há episódio depressivo atual importante;
- há uso de cannabis, estimulantes, álcool ou sedativos;
- há trauma com hipervigilância e esquiva;
- há instabilidade afetiva episódica sugerindo bipolaridade;
- há demanda primária por laudo, benefício ou medicação;
- há relato muito organizado, sem exemplos concretos de prejuízo;
- há discrepância grande entre relato e funcionamento observado/documental.

5. TDAH versus queixas modernas de atenção

Muita gente hoje tem atenção fragmentada por ambiente digital, excesso de demanda, sono ruim e ansiedade. Diferenciar:

TDAH provável

- padrão desde cedo;

- prejuízo em múltiplos contextos;
- desorganização crônica;
- dificuldade de autorregulação mesmo quando quer melhorar;
- histórico familiar frequente;
- sintomas persistem fora de fases de estresse.

Sobrecarga/estilo de vida provável

- início recente;
- piora proporcional a volume de trabalho, telas ou sono;
- melhora clara em férias/descanso;
- sem história escolar compatível;
- prejuízo mais situacional.

6. Roteiro rápido para primeira consulta

Abertura

1. Qual problema concreto te trouxe aqui?
2. Por que agora?
3. O que você espera da avaliação?

História atual

1. Quais sintomas aparecem no trabalho/estudo?
2. Quais aparecem em casa?
3. Quais aparecem nos relacionamentos?
4. Quais causam prejuízo real?

História longitudinal

1. Como era na infância?
2. Como era na escola?
3. Havia esquecimentos, bilhetes, advertências, bagunça, impulsividade, “vive no mundo da lua”, potencial maior que rendimento?
4. Como foi faculdade/residência/trabalho inicial?

Diagnóstico diferencial

1. Como está o sono?
2. Humor deprimido? Anedonia? Lentificação?
3. Ansiedade/ruminação?
4. Trauma/hipervigilância?
5. Episódios de energia aumentada, redução de sono e grandiosidade?
6. Uso de substâncias?
7. Doenças clínicas/medicações?

Fechamento

1. Quais são os três prejuízos que, se melhorassem, fariam diferença real?
2. Há alguém que possa confirmar a história longitudinal?

7. Escalas: como usar sem virar refém delas

Escalas ajudam a organizar sintomas e monitorar resposta, mas não fecham diagnóstico sozinhas.

Usos bons:

- rastreio;
- linha de base;
- comparação pré/pós-tratamento;
- coleta de múltiplos informantes;
- documentação clínica.

Usos ruins:

- “deu alto, então é TDAH”;
- ignorar depressão, ansiedade, sono e substâncias;
- usar escala adulta sem história infantil;
- confundir sofrimento subjetivo com prejuízo funcional objetivo.

8. Devolutiva diagnóstica boa

Uma devolutiva útil costuma ter esta estrutura:

1. “Há sintomas compatíveis com TDAH.”

2. “Eles parecem/não parecem estar presentes desde o desenvolvimento.”
3. “Há prejuízo funcional em...”
4. “Também há fatores que confundem ou agravam, como...”
5. “Minha conclusão neste momento é...”
6. “O plano é...”

Evitar devolutivas absolutas quando ainda faltam dados:

- “Você tem TDAH com certeza” na primeira consulta, sem história longitudinal.
- “Você não tem TDAH” só porque é inteligente, formado ou bem-sucedido.

9. Formulação clínica prática

Modelo curto:

Paciente apresenta padrão persistente de [inatenção/impulsividade/desorganização], com início provável em [fase], prejuízo atual em [domínios] e presença em [contextos]. O quadro é compatível com [hipótese]. Diferenciais relevantes incluem [lista]. Comorbidades identificadas: [lista]. O plano inicial será [plano].

10. Psicoeducação que costuma funcionar

Frases úteis:

- “TDAH não é falta de caráter; é dificuldade de autorregulação.”
- “O problema não é saber o que fazer, é conseguir fazer na hora certa.”
- “Motivação, novidade, urgência e recompensa imediata costumam melhorar o desempenho.”
- “Tratamento bom não depende só de força de vontade; depende de desenhar ambiente.”
- “Remédio ajuda muito, mas não organiza agenda sozinho.”

11. Intervenções ambientais simples para prescrever

Para muitos pacientes, isso vale mais que discurso longo:

- uma agenda única;
- lista diária com no máximo 3 prioridades;

- alarme para iniciar, não apenas para terminar;
- tarefas quebradas em blocos de 10–25 minutos;
- lembretes visuais;
- objetos sempre no mesmo lugar;
- reduzir fricção para começar tarefa;
- revisar agenda no mesmo horário todo dia;
- compromisso externo/prestação de contas;
- bloquear distrações digitais no período de foco;
- transformar tarefa abstrata em próxima ação física.

Exemplo: trocar “estudar” por “abrir PDF na página 12 e ler 3 páginas por 20 minutos”.

12. Farmacoterapia: pontos práticos de consulta

Antes de iniciar

- confirmar hipótese diagnóstica;
- medir PA, FC, peso, sono e apetite;
- investigar história cardiovascular relevante;
- investigar bipolaridade, psicose, uso de substâncias e risco de abuso;
- alinhar expectativa: melhora de execução, não “virar outra pessoa”.

Durante titulação

Monitorar:

- atenção sustentada;
- início de tarefas;
- impulsividade;
- irritabilidade/rebote;
- ansiedade;
- sono;
- apetite/peso;
- PA/FC;
- duração do efeito;
- funcionamento real, não só sensação subjetiva.

Pergunta de seguimento útil

Em que situação concreta da sua semana você percebeu diferença funcional?

Se a resposta é só “me senti mais ligado”, sem ganho funcional, reavaliar dose, alvo, diagnóstico ou expectativas.

13. Quando suspeitar que a medicação não é o principal problema

- paciente dorme 4–5h/noite;
- agenda é caótica e sem qualquer estrutura;
- ansiedade/depressão grave domina o quadro;
- uso de substância está ativo;
- há conflito conjugal/familiar intenso mantendo desorganização;
- paciente espera que medicação substitua rotina;
- não há adesão regular;
- melhora atenção, mas prejuízo segue por esquivas, perfeccionismo ou medo.

14. TDAH e comorbidades: hierarquia prática

TDAH + ansiedade

Tratar os dois. Ansiedade pode ser secundária à desorganização crônica, mas também pode simular TDAH. Observar se a desatenção reduz quando a ruminação melhora.

TDAH + depressão

Se depressão é moderada/grave, estabilizar humor e energia. Depois reavaliar resíduo atencional longitudinal.

TDAH + bipolaridade

Não iniciar estimulante sem estabilização do humor quando houver suspeita relevante. Diferenciar impulsividade crônica de episódio de aceleração.

TDAH + uso de substâncias

Avaliar temporalidade. TDAH pode aumentar risco de uso, mas substância ativa pode invalidar avaliação atencional.

TDAH + trauma

Trauma gera atenção capturada por ameaça. TDAH gera falha de autorregulação ampla e precoce. Podem coexistir.

15. Erros comuns do psiquiatra clínico

- Diagnosticar TDAH em toda queixa de atenção.
- Descartar TDAH em paciente com alta escolaridade.
- Não perguntar história infantil.
- Não pedir exemplos concretos de prejuízo.
- Ignorar sono.
- Ignorar bipolaridade.
- Tratar escala, não paciente.
- Usar medicação sem alvo funcional definido.
- Não combinar tratamento medicamentoso com organização ambiental.
- Confundir melhora subjetiva com melhora funcional.

16. TDAH em pacientes de alta performance

Médicos, advogados, empresários e pessoas muito inteligentes podem compensar por anos.

Sinais comuns:

- dependência de urgência extrema;
- produtividade em surtos;
- caos administrativo invisível;
- procrastinação com sofrimento intenso;
- secretária/cônjuge/sócio funcionando como “lobo frontal externo”;
- custo emocional alto para manter desempenho;
- colapso quando aumentam demandas simultâneas.

Nesses casos, investigar prejuízo por custo de compensação, não apenas por resultado externo.

17. TDAH e atestados/laudos

Para documentos clínicos:

- descrever diagnóstico e prejuízo funcional;
- evitar afirmar incapacidade ampla sem análise funcional;
- especificar limitações observadas;
- sugerir adaptações objetivas quando cabível;
- separar relato do paciente de achado clínico;
- evitar linguagem como “incapaz para tudo” sem base.

Formulação segura:

O diagnóstico de TDAH pode acarretar prejuízos em organização, atenção sustentada, controle impulsivo e gestão de prazos. No caso concreto, foram observados prejuízos em [domínios], recomendando-se [medidas], sem que isso implique, por si só, incapacidade global.

18. Mini-algoritmo de consulta

1. Queixa de atenção → investigar sono, humor, ansiedade, substâncias e contexto.
2. Se sintomas são crônicos e desde cedo → investigar TDAH.
3. Se há prejuízo em múltiplos contextos → aplicar escalas e buscar informante/documentos.
4. Se diagnóstico provável → psicoeducação + metas funcionais + plano ambiental.
5. Se prejuízo moderado/grave → considerar farmacoterapia.
6. Reavaliar resposta por funcionamento concreto.
7. Se resposta parcial → ajustar dose, rotina, comorbidades e diagnóstico diferencial.

19. Metas funcionais úteis

Boas metas:

- chegar no trabalho no horário 4/5 dias;
- pagar contas sem atraso por 2 meses;
- entregar relatório semanal até sexta;
- reduzir multas/infrações;

- estudar 25 minutos por dia;
- manter rotina de sono por 14 dias;
- reduzir discussões impulsivas com estratégia de pausa;
- organizar medicação em caixa semanal.

Metas ruins:

- “ter mais foco”;
- “ser normal”;
- “parar de procrastinar”;
- “melhorar tudo”.

20. Regra final para prática diária

No TDAH, o melhor tratamento combina:

- diagnóstico bem fundamentado;
- alvo funcional claro;
- psicoeducação sem moralismo;
- ambiente externo estruturado;
- manejo de comorbidades;
- farmacoterapia quando indicada;
- monitoramento longitudinal.

A pergunta de acompanhamento deve ser sempre:

O que mudou na vida real?